ICS **.***.**
C**

团体标准

T/CACM ****—20**

糖尿病性冠心病湿热证诊断标准

Diagnostic Criteria for Dampness-Heat Syndrome of Diabetic Coronary Heart Disease

（文件类型：公示稿）

CACM公示稿

20**-**-**发布 20**-**-**实施

中华中医药学会发布

目　次

前言 I
引言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　诊断原则和依据 4
附录 A 6
附录 B 7
参考文献 9

CACM公示稿

前　言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、T/CACM 1336-2020《基于病证结合的中医证临床诊断标准研制与应用规范》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东药科大学提出。

本文件由中华中医药学会归口。

本文件起草单位：广东药科大学、甘肃中医药大学、浙江中医药大学心脑血管研究所、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、广州中医药大学第一附属医院、中国中医科学院、中国中医科学院西苑医院、北京中医药大学、北京中医药大学东直门医院、首都医科大学附属北京中医医院、天津中医药大学第一附属医院、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、广东药科大学附属第一医院、暨南大学中医学院、广东省人民医院、中山大学附属第一医院、河南省中医院、河南中医药大学第一附属医院、江西中医药大学附属医院、浙江中医药大学、陕西中医药大学附属医院、陕西省中医医院、新疆医科大学、中山市中医院。

本文件主要起草人：郭姣、李应东、万海同、周嘉、吴伟。

本文件其他起草人：王振涛、毛静远、史大卓、兰天、朴胜华、朱明军、刘中勇、刘红旭、安冬青、苏衍进、李乐愚、杨洁红、吴秀艳、沈璐、张腾、陈青松、陈家旭、林谦、周万兴、赵晖、荣向路、钟诗龙、段玉红、陶军、雷燕。

CACM公示稿

引　言

糖尿病性冠心病是指糖尿病并发或合并冠心病，是糖尿病大血管病变主要疾病之一，其发病率较非糖尿病冠心病高2-4倍[1-4]，美国心脏学会（AHA）也因此于1999年首次提出糖尿病是一种心血管病的新观念，并被广泛认可。美国国家胆固醇教育计划报告和欧洲的指南认为2型糖尿病是CHD等危症，因此将其归为最高风险组[5-6]，糖尿病患者的心血管疾病也是糖尿病患者的主要死亡原因[7]，糖尿病冠心病的防治对降低患者心血管事件和死亡率至关重要。

湿热证是临床常见证型[8-9]，十二五规划教材《中医内科学》中载69种疾病，30种有湿热证。临床研究也显示，湿热证在糖尿病冠心病中占比达30.1%[10]。糖尿病冠心病中医证候分布规律的文献和临床研究也表明，糖尿病冠心病的标实证除传统的痰浊、血瘀证外，湿热证在疾病证候演变中具有核心枢纽地位，但尚未引起足够的重视[11-12]。既往糖尿病冠心病的证候诊断标准中，湿热证的诊断标准未完全统一，有关“湿热”的表述大多结合了个人的临床经验，术语定义不够规范，诊断条目缺乏诊断权重，影响了证候诊断的规范性、一致性和可重复性，限制其在临床和科研中的应用。

为进一步落实《中医药标准化中长期发展规划纲要（2011-2020）》提出的“全面推进中医药标准体系建设”的重要任务，充分发挥中医药防治糖尿病冠心病的优势，本文件在系统回顾既往糖尿病性冠心病湿热证相关诊断标准的基础上（见附录B），结合国内外最新证候研究进展，规范相关术语及其定义，经过核心组专家多轮论证和2轮德尔菲法确定了糖尿病性冠心病湿热证临床诊断条目和权重赋值，经多中心临床研究确定了诊断阈值，并广泛征求了行业内专家的意见（见附录A），形成了首个糖尿病性冠心病单证诊断标准，为糖尿病性冠心病湿热证的临床诊疗与科学研究提供指导和帮助。

本文件制定的目的在于进一步规范糖尿病性冠心病湿热证的中医临床诊断。本文件内容涵盖糖尿病性冠心病湿热证及其诊断条目的中英文术语和定义，诊断条目的权重赋值、诊断阈值等。简明实用，可操作性强，具有指导性、普适性和可参照性，可作为临床实践、诊疗规范和质量评价的重要参考依据。本文件的颁布将有助于指导和帮助临床医师对糖尿病性冠心病湿热证进行规范化的中医诊断，充分发挥中医药的优势与特色，改善糖尿病性冠心病患者的临床结局。

本文件由于受到使用者地域、民族、种族等因素的影响，在具体实施过程中，可依照实际情况而定。

CACM公示稿

糖尿病性冠心病湿热证诊断标准

1 范围

本文件制定了糖尿病性冠心病湿热证的诊断依据和诊断原则。

本文件适用于各级中医(中西医结合)医疗机构、科研院所以及开展中医药服务的医疗机构，可供执业中医师(中西医结合)、执业助理中医师等对糖尿病性冠心病湿热证的临床诊断使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅该版本适用于本文件。凡无注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订版本）适用于本文件。

WS 397-2012 糖尿病筛查和诊断

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件

3.1

糖尿病 diabetes mellitus

糖尿病是由胰岛素分泌功能缺陷和(或)胰岛素作用缺陷所引起的，以慢性高血糖为主要特征的一组病因异质性的代谢性疾病。长期高血糖可引起多系统损害，导致眼、肾、神经、心脏、血管等组织器官慢性进行性病变、功能减退及衰竭。

[来源：WS 397-2012，3.1]

3.2

糖尿病性冠心病 diabetic coronary heart disease

糖尿病性冠心病是糖尿病患者动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）的主要疾病之一，指糖尿病并发或合并冠状动脉粥样硬化性心脏病，也是造成糖尿病患者死亡的主要原因。

3.3

湿热证 syndrome of dampness-heat

CACM公示稿

湿热证是以头身沉重，口苦，口黏腻，口臭，小便黄赤，大便黏腻不爽，舌红苔黄厚腻，脉滑数等为常见症的证候。病因分外感、内伤，本文件中湿热证术语不包含外感湿热。

3.4

身重 heavy body

身重是指患者自觉身体沉重，甚至活动不利，难以转侧的症状。

3.5

胸闷 oppression in chest

胸闷是指患者自觉胸中堵塞不畅，满闷不舒的症状。

3.6

口黏腻 sticky and greasy in mouth

口黏腻是指患者自觉口舌黏腻，涩滞不爽，甚至食不知味的症状。

3.7

小便黄赤 deep-colored urine

小便黄赤是指尿液颜色呈深黄、黄赤或黄褐，甚至尿如浓茶的症状。本证不包括尿血所致的尿色改变。

3.8

大便黏腻不爽 sticky stool with ungratifying defecation

大便黏腻不爽是指大便黏稠且自觉排便不畅感的症状。

3.9

头重 heavy sensation of head

头重是指患者自觉头部重坠或如被捆裹的症状。

3.10

CACM公示稿

心悸 palpitations

心悸是指患者自觉心脏跳动不安，常伴有心慌不安的症状。

3.11

心烦 vexation

心烦是指心中烦热郁闷的症状。

3.12

口苦 bitter taste in mouth

口苦是指患者自觉口中有苦味的症状。

3.13

肥胖 obesity

肥胖是指形体发胖壅肿，超乎常人的状态。体重超过标准体重20%以上，或体重指数（BMI）≥28kg/m²，或男性腰围≥90cm，女性腰围≥85cm。依据脂肪积聚部位，肥胖可分为中心型肥胖（腹型肥胖）和周围型肥胖（皮下脂肪型肥胖）肥胖通常用BMI进行判定，中心型肥胖用腰围来判定。

3.14

目眵多 goopy eyes

目眵多是指眼的分泌物较多的症状。

3.15

面垢 dirty face

面垢是指脸色灰暗，如蒙尘土污垢，洗之不去的表现。

3.16

口臭 halitosis

口臭是指患者自觉或他觉口中出气臭秽的症状。

CACM公示稿

3.17

舌质红 red tongue

舌质红是指舌体比正常的淡红色颜色深的舌象。

3.18

舌苔黄腻 slimy yellow tongue fur

舌苔黄腻是指舌苔呈现黄色，苔质颗粒细腻致密，融合成片，如涂有油腻之状，紧贴舌面，揩之不去，刮之不脱的舌象。

3.19

舌苔厚 thick tongue fur

舌苔厚是指不能透过舌苔见到舌体的舌象，又称不见底苔。

3.20

脉滑或脉滑数 slippery pulse or rapid-slippery pulse

脉滑指往来流利，应指圆滑，如盘走珠的脉象。脉数指脉来急速，一息五六至（相当于每分钟90～120次）的脉象。脉滑数者兼具以上2种特征。

4 诊断原则和依据

4.1 先诊断糖尿病性冠心病，在本文件中具体指 2 型糖尿病并发或合并冠状动脉粥样硬化性心脏病，凡是患者来就诊时，符合以下 4.2 和 4.3 的诊断时可做出糖尿病性冠心病的临床诊断。

4.2 2 型糖尿病诊断：有 2 型糖尿病史，或者符合中华医学会糖尿病分会《中国 2 型糖尿病防治指南（2020 版）》中 2 型糖尿病诊断标准[13]者。

4.3 冠状动脉粥样硬化性心脏病诊断：既往有冠心病史，或既往无冠心病史但符合《内科学（第 9 版）》中[14]，冠状动脉粥样硬化使血管腔狭窄或阻塞，或(和)冠状动脉功能性改变(痉挛)导致心肌缺血缺氧或坏死而引起的心脏病的诊断标准。

4.4 临床见症状条目累计积分≥16 分者可诊断为糖尿病性冠心病湿热证(具体见表 1)。

4.5 本文件可以与糖尿病性冠心病其他证候诊断标准合并使用。

4.6 本文件推荐用于糖尿病性冠心病湿热证诊断，是否可用于干预措施的临床疗效评价有待研究。

CACM公示稿

表1 糖尿病性冠心病湿热证诊断标准

指标类型	指标内容	权重赋值
症状	身重	3
	胸闷	3
	口黏腻	3
	小便黄赤	3
	大便黏腻不爽	3
	头重	2
	心悸	2
	心烦	2
	口苦	2
	肥胖	1
	目眵多	1
	面垢	1
	口臭	1
舌象	舌质红	3
	舌苔黄腻	3
	舌苔厚	2
脉象	脉滑或脉滑数	3

CACM公示稿

附录 A

（资料性）

本文件征求意见专家及学术秘书

本文件由科技部国家重点研发计划项目“湿热证在2型糖尿病中的临床演变规律及其核心病机和辨证标准的系统研究”（项目编号：2018YFC1704200）资助，首席科学家：郭姣。

本文件领域专家（共识）委员会（按姓氏笔画排序）：王元松、王阶、亓鲁光、方敬爱、方朝晖、邓奕辉、史伟、包崑、冯建华、刘小溪、刘允辉、刘玉宁、刘春华、闫镛、许建秦、孙伟、米佳、李长辉、李伟、李灿东、李征锋、李靖、杨叔禹、杨晓晖、吴坚、张志芳、张剑勇、张智海、陆灏、陈光星、陈曦、邵明义、尚文斌、周建扬、周珂、赵进东、赵昌林、赵玲、赵能江、战丽彬、柳尧、秦佳佳、钱国强、钱锐、徐英英、徐健众、徐鹏、高怀林、郭俊杰、陶丽玲、黄平、龚燕冰、崔云竹、黄平、傅南琳、鲁盈、温伟波、雷涛、熊莉华、魏日胞、魏戌、魏军平。

本文件秘书：朴胜华、黄晓强、陈智权。

CACM公示稿

附录 B

（资料性）

历年糖尿病性冠心病中医辨证标准·湿热证相关部分

表 A　历年糖尿病性冠心病中医辨证标准·湿热证相关部分

时间	标准来源	湿热证相关诊断标准
2003 年	杜军强.糖尿病中医药防治指南[M]. 北京：中国中医药出版社，2003	血中伏火消渴证：心火亢盛，渴欲冷饮，烦热急躁，口舌生疮，心烦失眠，心悸怔忡，小便短赤，大便秘结，舌红苔黄，脉数或喜数
2006 年	吴以岭. 糖尿病性心脏病中医诊疗方案[A]. 中华中医药学会糖尿病分会.第九次全国中医糖尿病学术大会论文汇编[C].中华中医药学会糖尿病分会:中华中医药学会糖尿病分会,2006:11.	心脾气虚，痰浊瘀阻证：消渴病形体肥胖，胸闷憋气，心下痞满，胸脘作痛，痛引肩背，倦怠乏力，肢体重着，大便不爽，舌体胖大，边有齿痕，舌质暗淡，苔白腻或黄腻，脉弦滑或濡。
2011 年	吴以岭,高怀林,贾振华,袁国强,魏聪,倪青,仇菲,范冠杰,庞国明,闫镛,方朝晖.糖尿病合并心脏病中医诊疗标准[J].世界中西医结合杂志,2011,6(05):455-460.	痰浊阻滞证：胸闷痛如窒，痛引肩背,心下痞满,倦怠乏力，肢体重着 ,形体肥胖，痰多 ,舌体胖大或边有齿痕，舌质淡或暗淡 ，苔厚腻或黄腻 ,脉滑 。
2016 年	仝小林.糖尿病中医药临床循证实践指南[M].北京：科学出版社，2016	痰热互结证：形体肥胖，腹部胀大，口干口渴。胸闷脘痞，喜冷饮，饮水量多，心烦口苦，大便干结，小便色黄，舌质红，舌体胖，苔黄腻，脉弦滑。 热盛伤津：口大渴，汗多，乏力。喜冷饮，饮水量多，易饥多食，尿频量多，口苦，溲赤便秘，舌干红，苔黄燥，脉洪大而虚。

CACM公示稿

2017 年	世界中医药学会联合会糖尿病专业委员会. 糖尿病及其并发症本虚标实证候诊断标准[C]//世界中医药学会联合会糖尿病专业委员会专家文集（第十四辑）,北京:世界中医药学会联合会, 2017: 632-639.	标实证·湿热证：①头晕沉重，或腰腿酸困，或肢体沉重，或脘腹痞闷，或胀满，或恶心食少，②口中黏腻，或口甜，③大便粘滞不爽，或小便黄赤、涩痛，或妇女白带多、味重，④舌质红，舌苔黄腻，⑤脉濡滑，或滑数。具备①②③任 2 项，或任 1 项加④⑤1 项，即可判定。
2019 年	郭姣.糖脂代谢病（瘅浊）中西医结合诊疗技术规范[J].世界中医药,2019,14(03):771-782.	湿热内蕴 脘腹胀闷，面垢油光，口苦，目赤多眵，纳呆厌食，肢体困重，身热不扬，小便短黄，大便黏腻臭秽不爽，舌红苔黄腻，脉滑数。

CACM公示稿

参 考 文 献

[1] Kannel W. B., McGee D. L. Diabetes and cardiovascular risk factors: the Framingham study[J].Circulation,1979,59(1):8-13.

[2] Stamler J., Vaccaro O., Neaton J. D., et al. Diabetes, other risk factors, and 12-yr cardiovascular mortality for men screened in the Multiple Risk Factor Intervention Trial[J].Diabetes Care,1993,16(2):434-444.

[3] Emerging Risk Factors Collaboration, Sarwar N., Gao P., et al. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies[J].Lancet (London, England),2010,375(9733):2215-2222.

[4] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南（2020 年版）[J].中华糖尿病杂志,2021,13(4):315-409.

[5] National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report[J].Circulation,2002,106(25):3143-3421.

[6] De Backer Guy, Ambrosioni Ettore, Borch-Johnsen Knut, et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: third joint task force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts)[J].European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation: Official Journal of the European Society of Cardiology, Working Groups on Epidemiology & Prevention and Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology,2003,10(4):S1-S10.

[7] Grundy S. M., Benjamin I. J., Burke G. L., et al. Diabetes and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association[J].Circulation,1999,100(10):1134-1146.

[8] 项磊,朴胜华,荣向路,等.湿热证病证分布规律探析[J].世界中医药,2018,13(10):2621-2624.

[9] 林育,项磊,肖雪,等.基于临床研究的湿热证文本信息挖掘[J].广东药科大学学报,2017,33(05):654-658.

[10] 李赛美,李易崇,李伟华,等.糖尿病心脏病证候特征及演变规律探讨[J].中华中医药杂志,2007(08):574-575.

[11] 朱子勤,詹会霞,项磊,等.糖尿病合并冠心病中医证候研究进展[J].中国中医药现代远程教育,2019,17(06):119-122.

[12] 朱子勤,詹会霞,项磊,等.基于临床文献的糖尿病冠心病中医证候分布规律研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2019,21(03):465-470.

CACM公示稿

[13] 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南（2020年版）[J].中华糖尿病杂志,2021,13(4):315-409.

[14] 葛均波, 徐永健, 王辰. 内科学(第9版)[M]. 北京:人民卫生出版社, 2018.

CACM公示稿